

Mayo fue un buen mes dentro de un año que todavía no lo es

El ingreso del mes subió 20,0% frente a mayo de 2025 y el resultado cerró en \$51M. El acumulado, en cambio, deja -\$50M tras 5 meses: 105,8% menos que el año pasado.

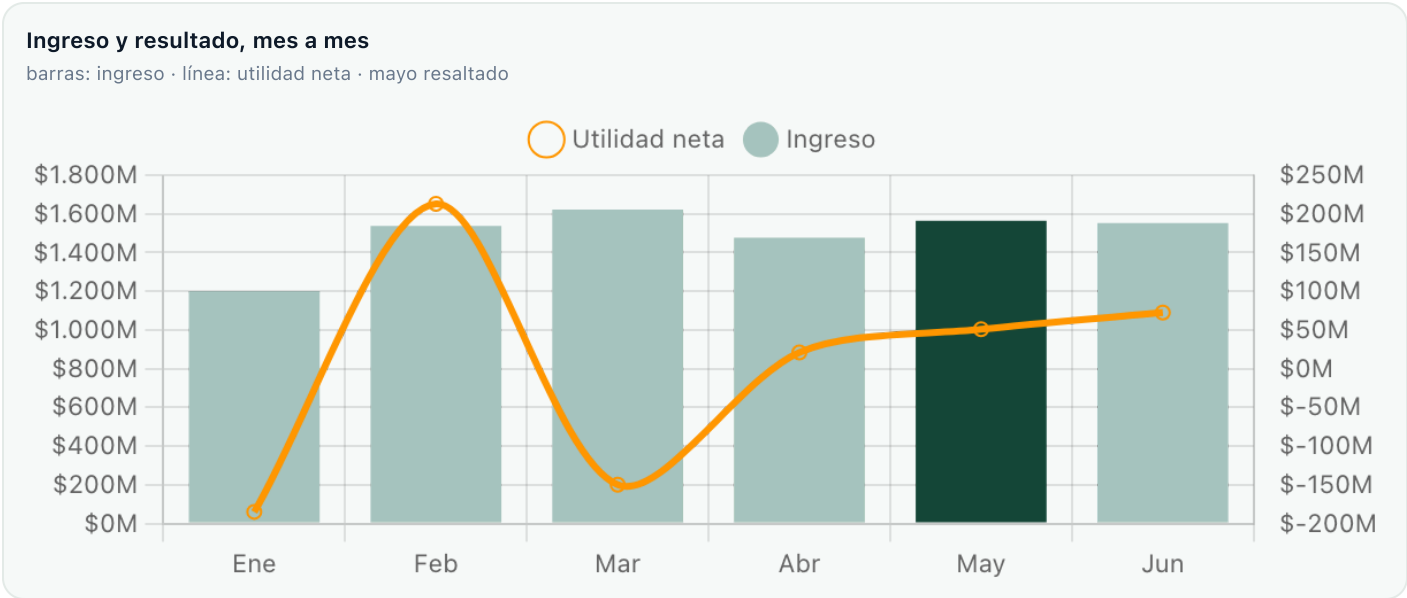
\$1.565M ▲ 20,0% Ingreso de mayo	\$51M ▼ 74,0% Resultado del mes	\$7.404M ▲ 35,9% Ingreso acumulado · ene-may	-\$50M ▼ 105,8% Resultado acumulado
--	---	--	---

Hay una escena que resume el año mejor que cualquier tabla: el quirófano lleno y la utilidad que no aparece. En mayo entraron \$1.565M —el mejor mayo del que se tenga registro— y el mes cerró con \$51M. Pero al mirar los seis meses juntos, el ingreso creció 35,9% y la utilidad acumulada quedó en -\$50M: 105,8% por debajo de la del año pasado.

La pregunta, entonces, no es si el negocio está creciendo —lo está, y rápido—. La pregunta es por qué ese crecimiento no está llegando abajo. Este informe recorre esa distancia: de dónde vino el ingreso, en qué se fue, quién opera, quién paga y cuánta sala se está usando de la que ya se paga —hoy el 36,5%—. La conclusión está al final, pero se adelanta acá: el problema no es de demanda.

Qué pasó en el mes

El ingreso de mayo fue \$1.565M, que subió 20,0% frente al mismo mes de 2025. El costo directo se movió en la misma dirección pero con otra fuerza: \$969M, 26,3% más que hace un año, lo que dejó una utilidad bruta de \$596M — un margen de 38,1%. Después de la estructura, el mes cerró con \$51M de utilidad neta, frente a \$21M del mes anterior.

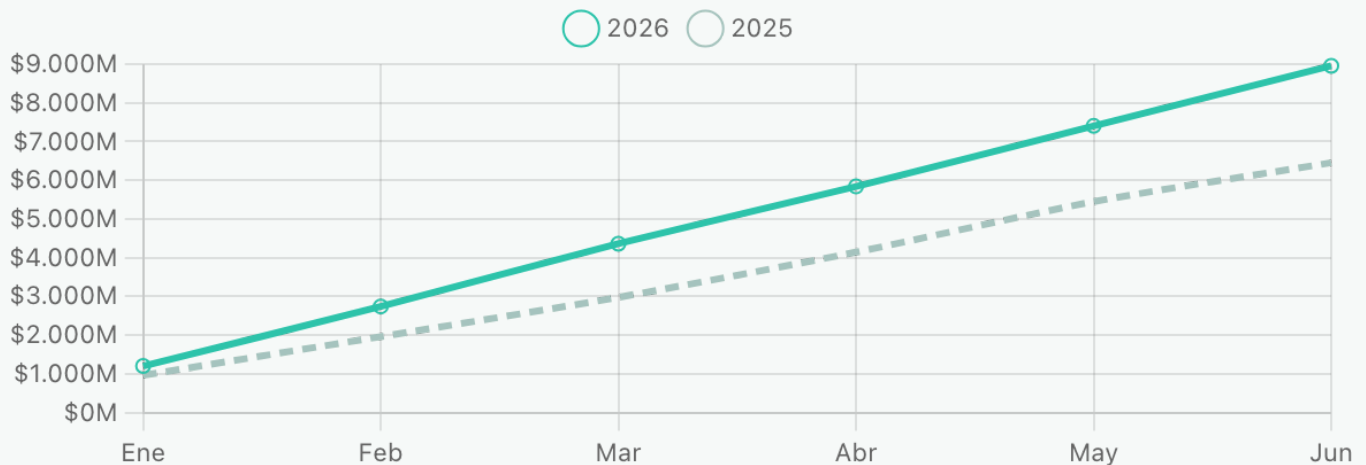


Cómo va el año

En los primeros 5 meses el ingreso acumulado llega a \$7.404M, 35,9% por encima de los \$5.448M del mismo período de 2025. La utilidad acumulada es -\$50M contra \$859M: una caída de 105,8%. El margen neto del año va en -0,7%, y el EBITDA acumulado en \$347M.

Acumulado 2026 contra 2025

suma corrida del ingreso, mes a mes

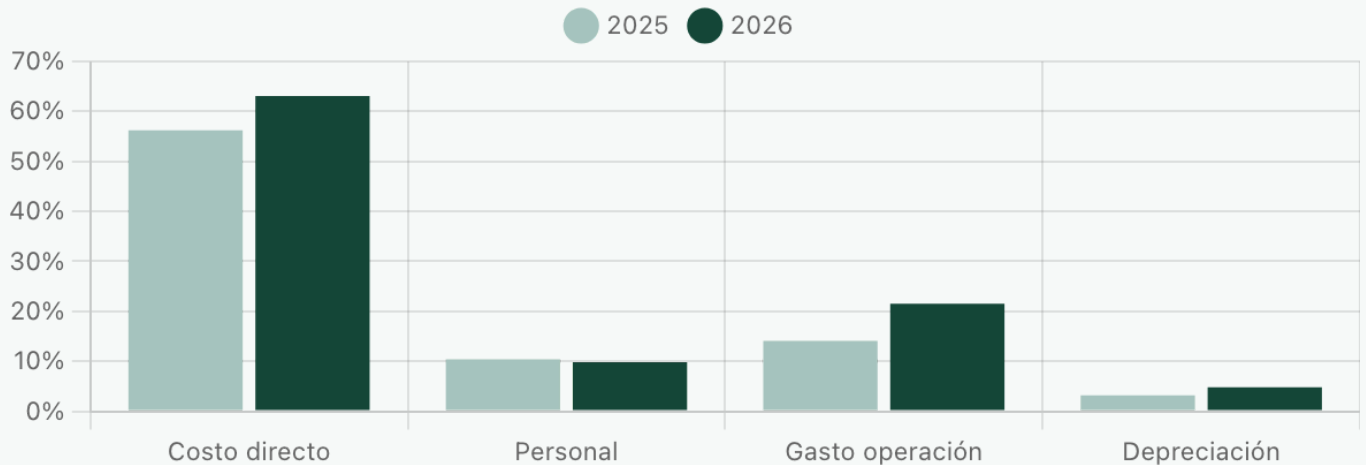


De dónde salió el resultado

De cada cien pesos que entraron en el año, 63 se fueron en costo directo, contra 56 del año pasado: una pérdida de 6.9 puntos de margen. La estructura —personal, gasto de operación y depreciación— sumó \$2.677M en el acumulado, de los cuales \$726M son personal y \$359M depreciación. Es ahí, y no en el volumen, donde se define si el crecimiento llega abajo.

A dónde va cada cien pesos de ingreso

acumulado ene-may, 2025 contra 2026

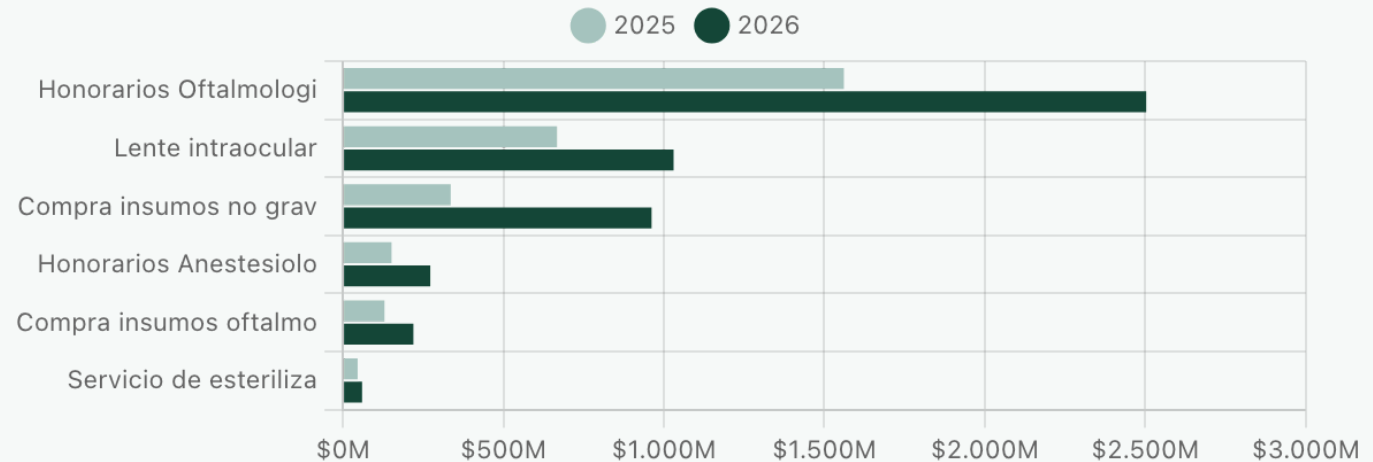


El costo directo, por dentro

En el acumulado el costo directo suma \$4.672M y se reparte en tres bloques: honorarios oftalmología \$2.503M (50% del costo); lente intraocular \$1.030M (20% del costo); compra insumos no gravados \$962M (19% del costo). Los honorarios son el rubro que manda —50% del costo— y se mueven con el volumen, así que su crecimiento no es en sí una señal; lo que hay que mirar es si crecen MÁS rápido que el ingreso. El lente intraocular pesa \$1.030M y los insumos \$962M: son los dos rubros donde una negociación de tarifa se ve en el mes siguiente.

El costo directo, cuenta por cuenta

acumulado ene-may · en millones

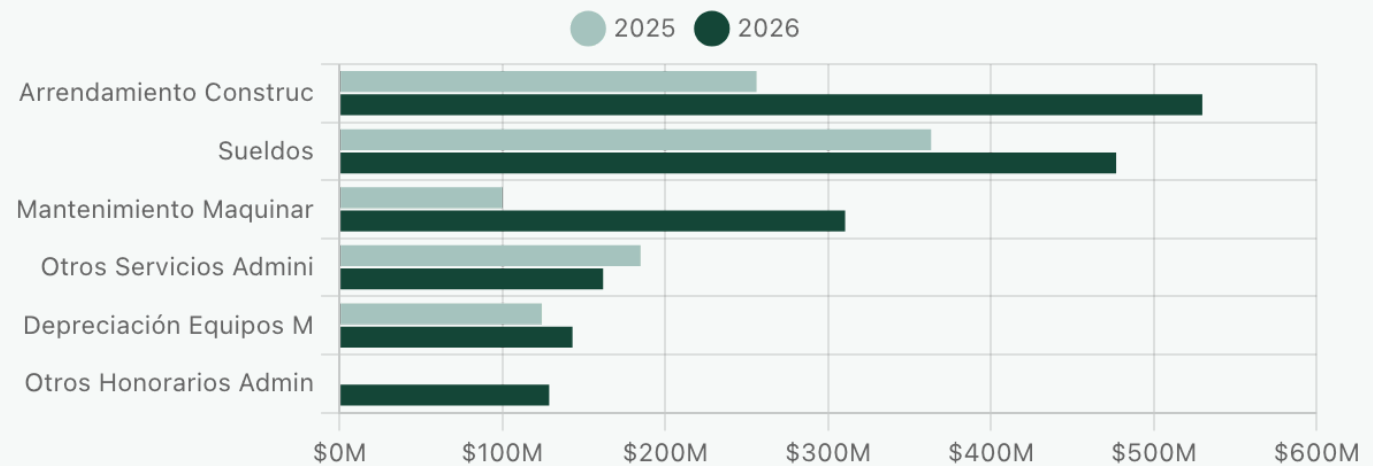


El gasto de estructura

La estructura acumulada suma \$2.677M, que es 36,2% del ingreso del año. Los cuatro rubros que la explican son arrendamiento construcciones y edificaciones administración \$530M; sueldos \$477M; mantenimiento maquinaria y equipo administración \$311M; otros servicios administración \$162M. A diferencia del costo directo, esta base no se mueve con el volumen: es la que determina cuántas cirugías hacen falta para que el mes cierre en positivo. Por eso llenar quirófano tiene un efecto tan directo — cada procedimiento adicional entra sobre una estructura ya pagada.

El gasto de estructura

los rubros que más pesan · acumulado ene-may

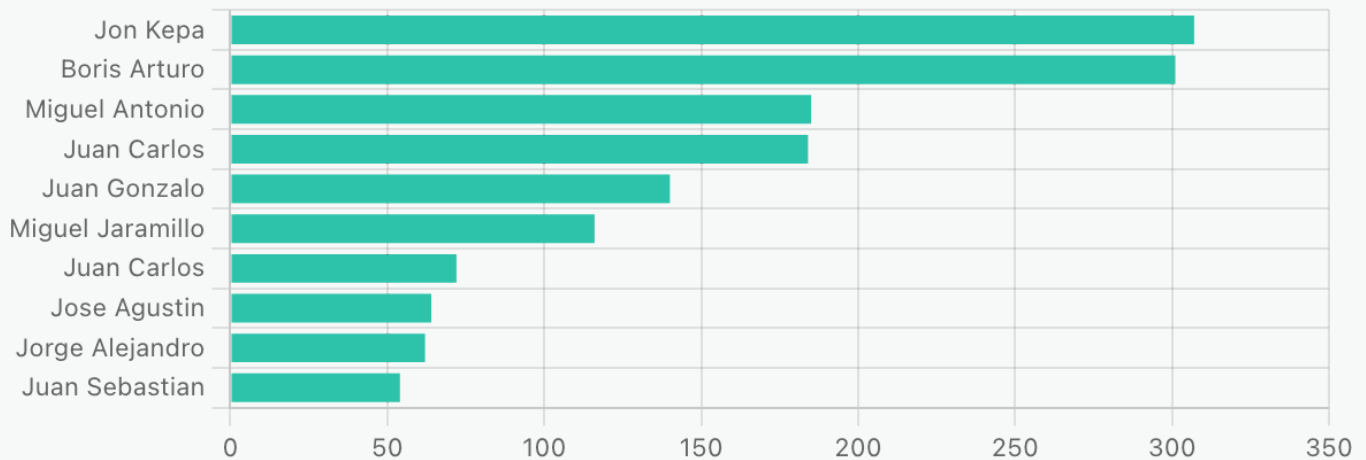


Quién opera, y con qué peso

48 cirujanos operaron en lo corrido del año, y los cinco primeros concentran 59% de las cirugías. Pero el ranking cambia según cómo se mire, y esa diferencia es el dato: por número de cirugías encabeza Jon Kepa Balparda con 307; por horas de quirófano encabeza Jon Kepa Balparda con 118 horas. Un cirujano refractivo hace muchos procedimientos de veinte minutos y otro hace pocos de dos horas: cuentan distinto en la agenda, en el consumo de sala y en el resultado. Medir solo por conteo premia al primero y esconde cuánta capacidad consume el segundo.

Los cirujanos que mueven el volumen

procedimientos en el año · los diez primeros

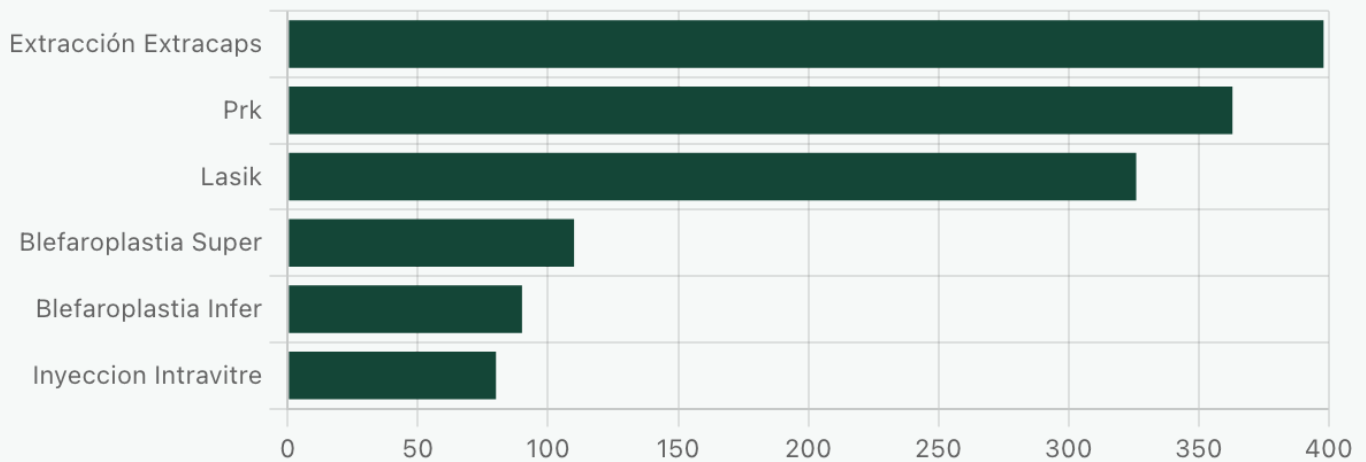


Qué se opera y con qué lente

La mezcla del año la encabezan extracción extracapsular a 398 (\$2,9M por procedimiento); prk 363 (\$0,9M por procedimiento); lasik 326 (\$0,9M por procedimiento). La diferencia de tarifa entre procedimientos es lo que hace que dos meses con el mismo número de cirugías dejen resultados distintos. En cuanto a lentes, se facturaron 459 unidades por \$1.199M, sobre 1.975 derechos de sala: una penetración de 20%. El lente es a la vez ingreso y costo, así que su margen depende de la tarifa negociada, no del volumen.

Qué se opera

procedimientos del año por tipo · los seis primeros

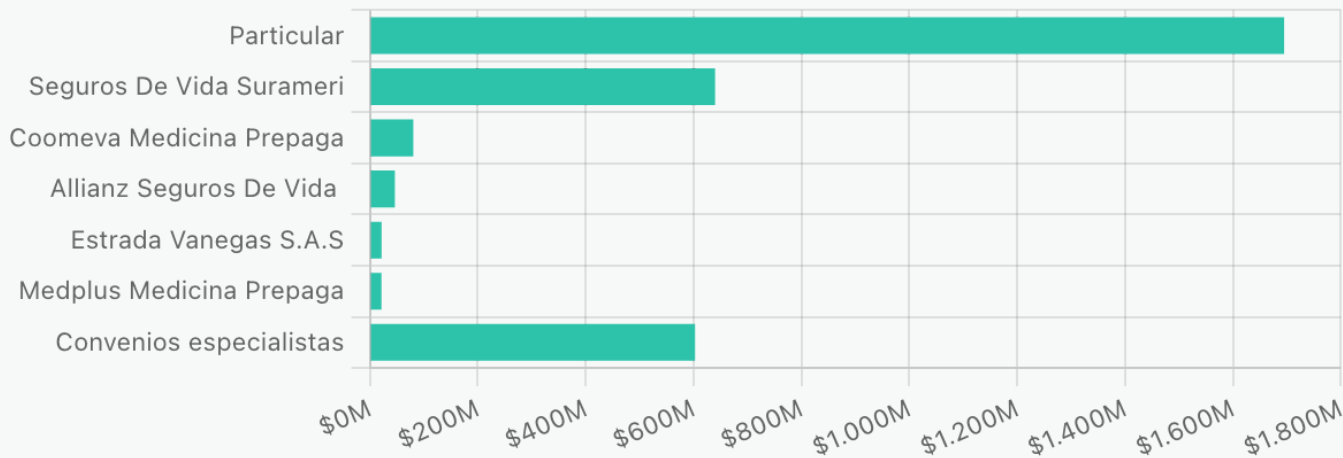


Quién paga

De los \$3.178M facturados en derechos de sala este año, el reparto por pagador es: Particular 53%; Seguros De Vida Suramericana S 20%; Coomeva Medicina Prepagada S.A 3%; Allianz Seguros De Vida S.A. 1%. El paciente particular pesa 53% del ingreso de sala, que es la porción que no depende de tarifa negociada ni de autorización previa — y por eso es la más rentable y la más volátil a la vez. La concentración en pocos pagadores define el poder de negociación: cuando una sola entidad pesa más de un tercio, la renegociación de su tarifa deja de ser un trámite y pasa a ser un evento de resultado.

Quién paga los derechos de sala

acumulado ene–may · participación del ingreso



La capacidad que no se usa

Los tres espacios quirúrgicos operaron al 36,5% de su capacidad en lo corrido del año: 1.389 horas reservadas de 3.801 disponibles, dejando 2.412 horas de sala que se pagan y no producen. La medición es por espacio reservado —la sala se aparta en bloques y si la cirugía termina antes ese tiempo ya no se vende—, con la ventana de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y sábados hasta las 12:00. El mapa de abajo muestra dónde está el hueco: cada celda es una hora de un día de la semana, en verde lo disponible y en rojo lo ocupado.

Dónde está la sala libre

cada celda es una hora de un día · verde disponible, rojo ocupada · promedio del año

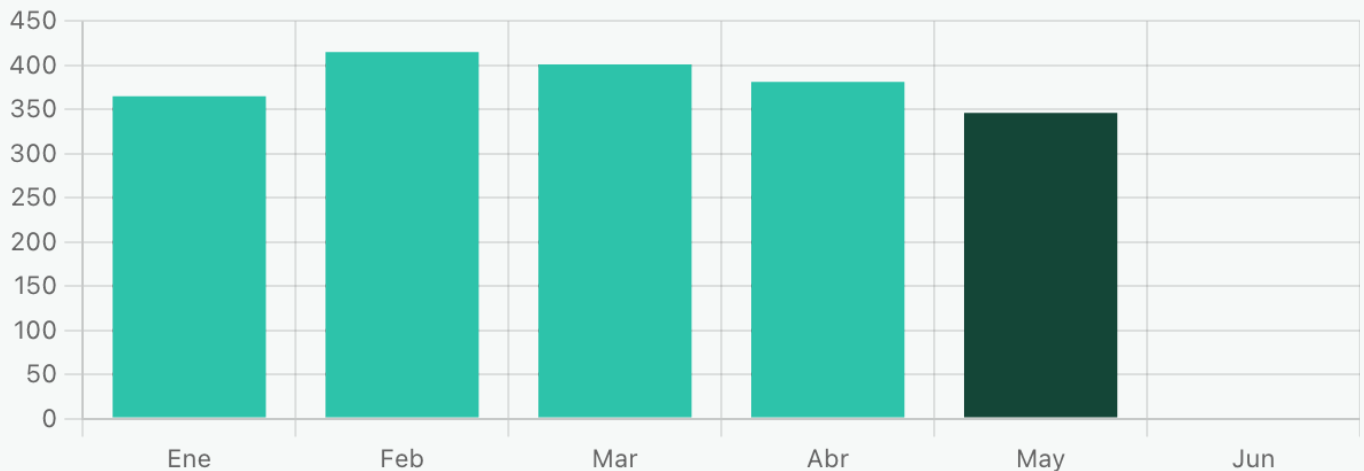
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Lun	27	29	37	27	26	27	15	23	34	32	29	17
Mar	9	18	29	35	30	23	22	27	33	44	40	25
Mié	25	41	37	30	34	27	27	36	37	32	31	18
Jue	27	52	57	51	46	35	31	46	57	45	43	21
Vie	43	60	59	53	48	45	37	52	47	45	45	22
Sáb	32	58	57	50	40							

La operación

En mayo se realizaron 345 procedimientos, 13,5% más que en mayo de 2025, y 1.894 en lo corrido del año. El ingreso por procedimiento del mes fue \$4,5M. La lectura útil no es solo cuántos se hicieron sino a qué tarifa: si el volumen sube y el ingreso por procedimiento baja, el crecimiento se está comprando con precio.

Cirugías por mes

cirugías únicas · fuente: agenda quirúrgica



Qué hay que decidir

El costo directo gana margen

Pesa 6.9 puntos más del ingreso que el año pasado. Sobre el acumulado de \$7.404M, cada punto son \$74M. Definir si es mezcla de procedimientos, tarifa de insumos o ambos.

El crecimiento no llega abajo

El ingreso creció 35,9% y la utilidad cayó 105,8%. Es el hallazgo del año: se está operando más grande para ganar lo mismo o menos.

El margen no tiene colchón

El acumulado deja -0,7% de margen neto: un mes flojo se lleva el año. Vale la pena fijar un piso mensual y medirlo cada cierre.

Conclusiones

El margen se está yendo por el costo directo, no por el gasto

El costo directo pasó de 56,2% a 63,1% del ingreso. Sobre el acumulado de \$7.404M, esos 6.9 puntos son \$511M que dejaron de bajar al resultado. Como el rubro que manda son los honorarios y esos siguen al volumen, la palanca no es recortarlos sino revisar la tarifa de los dos que sí se negocian: lente e insumos.

Hay un negocio entero dentro del que ya existe

Las salas operan al 36,5% de su capacidad y quedan 2.412 horas al año que se pagan igual. No hace falta obra ni equipos: hace falta agenda. Cada hora que se llena entra sobre una estructura de \$2.677M que ya está causada, así que su efecto en el resultado es casi directo.

La agenda depende de pocas manos

Cinco cirujanos concentran 59% de las cirugías del año. Eso no es un problema hoy, pero sí una dependencia: vale la pena saber qué pasa con el mes si uno de ellos para dos semanas, y tener la respuesta antes de necesitarla.

Qué mirar el mes entrante

Tres cifras, en este orden: el costo directo como porcentaje del ingreso —hoy 63,1%—, la ocupación de sala —hoy 36,5%— y el ingreso por cirugía. Si las tres se mueven en la dirección correcta, el resultado llega solo. Si el ingreso crece y esas tres no se mueven, el mes siguiente se parecerá a este.

Las cifras, para verificar

RUBRO	MAY 2026	MAY 2025	ACUM. 2026	ACUM. 2025
Ingreso	\$1.565M	\$1.304M	\$7.404M	\$5.448M
Costo directo	\$969M	\$767M	\$4.672M	\$3.061M
Utilidad bruta	\$596M	\$537M	\$2.732M	\$2.386M
Personal	\$171M	\$117M	\$726M	\$568M
Gasto de operación	\$300M	\$181M	\$1.592M	\$770M
Depreciación	\$74M	\$37M	\$359M	\$172M
EBIT	\$51M	\$202M	\$55M	\$877M
EBITDA	\$125M	\$238M	\$347M	\$1.057M
Utilidad neta	\$51M	\$196M	-\$50M	\$859M